

FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

HISTORIA CLINICA - DOCUMENTO SINTETICO PARA HOL

Atencion en Urgencias - Servicio de Cardiologia

Paciente:	Carlos Andres Suarez Mendoza	Edad:	58 años
Genero:	Masculino	Fecha:	2026-05-12

Motivo de consulta

Dolor toracico opresivo de inicio subito hace 2 horas, irradiado a brazo izquierdo, asociado a diaforesis y nauseas.

Anamnesis (subjetivo)

Antecedente de HTA de 10 años, dislipidemia, fumador 20 paquetes-año. Padre con IAM a los 60. Niega alergias.

Examen fisico

TA 150/95 mmHg, FC 102 lpm, sat O2 94 por ciento, FR 22 rpm, T 36.8 C. Paciente diaforetico, palido. Ruidos cardiacos ritmicos sin soplos. Pulmones limpios. EKG: depresion del ST en cara inferior.

Diagnostico principal

Sindrome coronario agudo SCASEST - alta probabilidad. Troponina I inicial 0.08 ng/mL (elevada).

Plan terapeutico

Hospitalizacion en UCI coronaria. ASA 300mg dosis carga + 100mg/dia. Clopidogrel 600mg carga. Atorvastatina 80mg. Heparina enoxaparina 1mg/kg cada 12h. Coronariografia urgente. Monitoreo continuo. NPO.